

# PROTOCOLO DE ACESSO À ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA



Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE

2024



# MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



# VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

# VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



**PREFEITO**

Adriano Bornschein Silva

**SECRETÁRIO DA SAÚDE**

Rodrigo Andrioli

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Jocelita Cardozo Colagrande

**DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Marlene Bonow Oliveira

**DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE**

Douglas Calheiros Machado

**DIRETORIA TÉCNICA**

Luana Garcia Ferrabone

**GERÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA**

Mariana Luiza Faria Bergemann

**GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL**

Ana Cláudia Franz Schuch

**GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

Ana Aparecida Pereira – Distrito Norte

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Centro

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

**GERÊNCIA DE ENFERMAGEM E GESTÃO ASSISTENCIAL**

Vanessa Cardoso Pacheco

**GERÊNCIA DE REGULAÇÃO**

Franci Maiara Machado

**GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS**

Flavia Schwinden Müller

**COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL**

Maristela Mello de Aguiar

**ELABORAÇÃO – 2017**

Carine Juliana Gonçalves de Souza

Flávia Favaretto

Gislene Cristina Mantovani de Araújo

Lailah El Achkar

Patricia Luzia Johann Teochi

Rosane Regina de Almenau Goelzer

Rosimeire Pereira Bressan

Simone Aparecida de Souza

**ATUALIZAÇÃO E REVISÃO – 2024**

Aila Anne Pinto Farias Contarato

Fabiane Cherobin

Indianara da Silva

Janaína Pravato Vicente Banin

Michelli Aparecida Rosin

Valquíria Aparecida Duarte



## SUMÁRIO

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LISTA DE ANEXOS.....                                                                                                       | 5  |
| LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....                                                                                        | 6  |
| 1. PROTOCOLO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA.....                                                          | 7  |
| 2. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA.....                                                                       | 7  |
| 2.1. Laqueadura Tubária em Não Gestantes e Gestantes.....                                                                  | 7  |
| 2.2. Vasectomia.....                                                                                                       | 8  |
| 3. CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA FEMININA E MASCULINA.....                                           | 8  |
| 3.1. Critérios referentes à Documentação para o Processo.....                                                              | 9  |
| 4. ACESSO PARA SOLICITAÇÃO/ENCAMINHAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA: LAQUEADURA OU VASECTOMIA..... | 11 |
| 4.1. Na Laqueadura Tubária.....                                                                                            | 12 |
| 4.1.1. Usuária Não Gestante.....                                                                                           | 12 |
| 4.1.2. Usuária Gestante.....                                                                                               | 13 |
| 4.2. Na Vasectomia.....                                                                                                    | 13 |
| REFERÊNCIAS.....                                                                                                           | 15 |



## LISTA DE ANEXOS

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anexo 01.</b> Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Laqueadura Tubária.....       | <b>16</b> |
| <b>Anexo 02.</b> Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Vasectomia.....               | <b>17</b> |
| <b>Anexo 03.</b> Conferência de Documentação Obrigatória.....                                                      | <b>18</b> |
| <b>Anexo 04.</b> Declaração de Participação em Grupo ou Consulta de Enfermagem sobre Planejamento Reprodutivo..... | <b>19</b> |
| <b>Anexo 05.</b> Declaração Médica para Vasectomia.....                                                            | <b>20</b> |
| <b>Anexo 06.</b> Declaração Médica para Laqueadura.....                                                            | <b>21</b> |
| <b>Anexo 07.</b> Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Laqueadura Tubária para Gestantes.....            | <b>22</b> |
| <b>Anexo 08.</b> Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido para Laqueadura Tubária para Não Gestantes.....       | <b>24</b> |
| <b>Anexo 09.</b> Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido para Vasectomia.....                                  | <b>26</b> |
| <b>Anexo 10.</b> Orientações Pós Laqueadura Tubária.....                                                           | <b>28</b> |
| <b>Anexo 11.</b> Cuidados Pós Vasectomia.....                                                                      | <b>29</b> |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

**AIH:** Autorização de Internação Hospitalar

**APAC:** Autorização para Procedimento de Alto Custo

**APS:** Atenção Primária à Saúde

**CIAP:** Classificação Internacional de Atenção Primária

**CID-10:** Classificação Internacional de Doenças – 10ª revisão

**CCIH:** Central de Controle de Infecções Hospitalares

**CNS:** Cartão Nacional de Saúde

**COREN/SC:** Conselho Regional de Enfermagem / Santa Catarina

**CPF:** Cadastro de Pessoa Física

**CRM/SC:** Conselho Regional de Medicina/ Santa Catarina

**DIU:** Dispositivo Intrauterino

**HIV:** *Human Immunodeficiency Virus* (Vírus da Imunodeficiência Humana)

**IST:** Infecção Sexualmente Transmissível

**KTPP:** Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada

**LT:** Laqueadura Tubária

**Nº:** Número

**RG:** Registro Geral

**SEI:** Sistema Eletrônico de Informação

**SIG-SaudeTech:** Sistema Integrado de Gestão (Olostech)

**SISREG:** Sistema Nacional de Regulação

**SUS:** Sistema Único de Saúde

**TAP:** Tempo de Atividade da Protrombina

## 1. PROTOCOLO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA

O usuário deve receber orientações sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis no serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), e ao solicitar o procedimento de Laqueadura Tubária ou Vasectomia deve estar seguro da sua opção e ter sido orientado por profissionais da saúde sobre as vantagens e desvantagens desses procedimentos.

## 2. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA

### 2.1. Laqueadura Tubária em Não Gestantes e Gestantes

A Laqueadura Tubária (LT) ou Ligadura de Tubas Uterinas consiste no método de esterilização feminina caracterizado pelo corte e/ou ligamento cirúrgico das tubas uterinas, no qual impede-se o encontro do óvulo com os espermatozóides, impossibilitando assim a fecundação/gravidez.

#### → **Benefícios:**

- Não interfere nas relações sexuais;
- Não interfere na libido;
- Não tem efeitos sobre o leite materno;
- Não apresenta efeitos colaterais a longo prazo ou riscos à saúde.

#### → **Riscos:**

- Possíveis complicações: infecção, sangramento no local da incisão ou intra-abdominal, lesão de órgãos pélvicos ou abdominais e aderências;
- Internação e anestesia (dependendo da técnica utilizada);
- Há possibilidade mínima de 1% de ocorrer uma gravidez após a cirurgia. Caso ocorra, aumenta a chance de ser ectópica.

#### → **Contraindicações:**

- Infecções pélvicas ou sistêmicas agudas;
- Fatores que contraindicam a realização cirúrgica;
- Estar fora dos critérios estabelecidos na Lei nº 14.443, de 02 de setembro de 2022.

## 2.2. Vasectomia

A Vasectomia ou Deferentectomia é um método contraceptivo definitivo que consiste em secção e/ou oclusão do canal deferente, sendo um método seguro, eficaz e de fácil execução.

É um procedimento feito com anestesia local em cima do escroto, sem necessidade de internação.

É uma cirurgia de esterilização voluntária e eletiva, sendo o método contraceptivo a longo prazo mais eficiente que existe, estando entre as opções mais seguras para o planejamento familiar.

### → Benefícios:

- Não interfere nas relações sexuais;
- Não afeta o desempenho sexual do homem;
- Não apresenta efeitos colaterais a longo prazo ou riscos à saúde.

### → Riscos:

- Infecção e sangramento no local ou dentro da incisão e a formação de coágulos no escroto são complicações raras da cirurgia.

### → Contraindicações:

- Infecção local na pele ou escroto;
- Massa intra-escrotal;
- Infecção do trato genital masculino ou orquite;
- Distúrbios de coagulação.

## 3. CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA FEMININA E MASCULINA

Considerando o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, que teve a sua regulamentação na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, sendo esta alterada com a Lei nº 14.443, de 02 de setembro de 2022, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento reprodutivo.

Somente é permitida a Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva – Laqueadura

Tubária ou Vasectomia – sob as seguintes condições:

- Homens e Mulheres com capacidade civil plena, casados (as) ou não, maiores de 21 anos de idade (Lei N° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, Art. 10. inciso I);
- Homens e Mulheres com capacidade civil plena, casados (as) ou não, com pelo menos 02 (dois) filhos (Lei N° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, Art. 10. inciso I);
- Observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce (Lei N° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, Art. 10. inciso I);
- Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos (Lei N° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, Art. 10. inciso II).

### 3.1. Critérios referentes à Documentação para o Processo

O usuário ao manifestar interesse pelo método contraceptivo definitivo, deverá ser orientado pelo profissional da saúde sobre os demais métodos contraceptivos, por meio da educação sexual, assistência pré-natal e pós-natal e saúde reprodutiva (planejamento reprodutivo) para garantir uma escolha consciente do usuário.

Salientando que, a usuária gestante também deve passar pelas orientações acima e preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico para Gestante (Anexo 07. - “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária para Gestantes”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1) e assinado em 03 (três) vias (a data deve ser do dia em que a gestante manifesta o desejo em fazer a laqueadura).

Após esclarecimentos acima, será fornecido ao usuário uma declaração que comprova a sua participação na consulta ou no grupo de planejamento reprodutivo e também uma lista de documentos (Anexo 03. - “Conferência de Documentação Obrigatória”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1) a serem apresentados para continuidade do Processo.

### Documentação Obrigatória:

- Declaração de participação em planejamento reprodutivo (Anexo 04. - “Esterilização Cirúrgica Eletiva / Declaração”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1);
- Declaração médica do parecer favorável ao procedimento (Anexo 05. - “Esterilização Cirúrgica Eletiva - Vasectomia / Declaração Médica”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1, OU Anexo 06. - “Esterilização Cirúrgica Eletiva - Laqueadura Tubária / Declaração Médica”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1);
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo Requerente e pelo profissional Enfermeiro ou Médico da UBSF (Anexo 07. - “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária para Gestantes”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1, OU Anexo 08. - “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1, OU Anexo 09. - “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Masculina – Vasectomia”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1);
- Comprovante de residência;
- Documento oficial com foto e CPF;
- Certidão de Nascimento dos filhos vivos (quando houver);
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Para dar continuidade ao encaminhamento da cirurgia de esterilização voluntária e eletiva, é necessário que o usuário preencha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido condizente ao seu procedimento, e este deve ser assinado pelo requerente e pelo profissional Enfermeiro ou Médico da UBSF.

**Importante:** O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido expressa a manifestação da vontade do usuário, de forma escrita e firmada (**sem necessidade de registro em cartório**), conforme previsto na Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.

Ressaltamos que o prazo para a efetivação do processo de esterilização cirúrgica eletiva é no mínimo de 60 dias entre a manifestação de interesse do usuário ao processo até o ato cirúrgico.

#### **4. ACESSO PARA SOLICITAÇÃO/ENCAMINHAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA VOLUNTÁRIA E ELETIVA: LAQUEADURA OU VASECTOMIA**

O acesso para a solicitação e encaminhamento dos processos de Esterilização Cirúrgica Voluntária ocorre por meio do Serviço de Atenção Primária à Saúde - APS, conforme os fluxogramas apresentados nos Anexos 01 e 02 (Anexo 01. - “Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Laqueadura Tubária”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1, E Anexo 02. - “Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Vasectomia”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1), e seguirá os seguintes passos:

- a)** O usuário dirige-se a sua Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de referência, e expressa sua vontade de utilizar um método contraceptivo definitivo na recepção;
- b)** É agendada a Consulta de Enfermagem (na ausência deste profissional, encaminhar para Consulta Médica) ou participação no Grupo de Planejamento Reprodutivo onde serão realizadas algumas condutas:
  - Apresentação de todas as opções de métodos contraceptivos disponíveis para a escolha consciente do casal ou usuário (DIU; Anticoncepção Oral, Injetável, Vasectomia; Preservativo masculino e feminino);
  - Oferta de Testagem Rápida para Sífilis, Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e Hepatites Virais (sendo opcional a aceitação do usuário);
- c)** Caso o usuário mantiver a decisão após as orientações acima e preenchido os critérios legais, o profissional orienta e esclarece dúvidas sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que deverá ser assinado na data desta orientação e enviar para a Central de Regulação somente após 60 dias da assinatura;
- d)** O profissional também orienta sobre a possibilidade de procurar a UBSF quantas vezes forem necessárias para sanar suas dúvidas com a equipe de saúde ou manifestar desistência;
- e)** Encaminha o usuário para Consulta Médica (caso esteja sendo orientado pelo Enfermeiro) na UBSF;
- f)** O médico, em consulta, avalia os critérios e dá parecer clínico, entregando ao usuário a declaração médica sendo favorável ou não ao processo, devendo estar carimbado e assinado;

- g)** Médico orienta a agendar consulta com Enfermeiro (na ausência deste, agendar com outro profissional), em 60 dias, para entrega da documentação;
- h)** Na consulta de retorno, o profissional confere toda a documentação, preenche o documento “Conferência de Documentação Obrigatória”, colhe as assinaturas e orienta sobre a continuidade do processo;
- i)** O profissional digitaliza os documentos (exceto no caso de gestante, que levará a documentação no dia do parto) entregando os documentos originais ao usuário e orienta sobre a necessidade de apresentá-los no dia da cirurgia;
- j)** No descritivo do encaminhamento on-line, inserir dados clínicos e condições de Vulnerabilidade Social (alcoolismo, drogadição, grande múltipara, mulher em situação de violência), quando houver.

#### **4.1. Na Laqueadura Tubária**

##### **4.1.1. Usuária Não Gestante**

- a)** O profissional confere a documentação, solicita o procedimento no SIG-SaudeTech:
  - Consulta para Planejamento Familiar Laqueadura (código de procedimento - 99001081) (CID-10 - Z30.2 = Esterilização / CIAP - W13); e
  - Encaminha a documentação digitalizada para a Central de Regulação através do e-mail [laqueadura.joinville@gmail.com](mailto:laqueadura.joinville@gmail.com), identificando no assunto:
    - nome e sobrenome da usuária; e
    - o procedimento solicitado: Laqueadura (neste momento é necessário confirmar os dados cadastrais e telefones de contato informados no referido sistema);
- b)** O Médico Regulador prioriza o agendamento da consulta e autoriza o procedimento cirúrgico;
- c)** Médico Cirurgião Ginecológico:
  - Solicita os exames pré-operatórios:
    - Parcial de urina, hemograma, TAP e KTPP;
    - Eletrocardiograma e o Raio X de tórax são solicitados as usuárias com mais de 40 anos de idade ou quando necessário, com validade máxima de 6 meses;
  - Orienta os cuidados pré-operatórios;
  - Preenche a Autorização de Internação Hospitalar (AIH); e

- Encaminha, por malote, para a Central de Regulação (Secretaria da Saúde);
- d) Regulação do Município: Recebe a AIH e insere no Sistema de Regulação Estadual (SISREG);
- e) Regulação do Estado: autoriza o procedimento, insere em mapa cirúrgico e comunica a Central de Regulação do Município e Hospital Executante;
- f) Hospital Executante:
  - Agenda o procedimento e avisa a usuária sobre data da cirurgia;
  - Realiza o procedimento;
- g) Médico Cirurgião Ginecológico: orienta os cuidados no pós-operatório imediato (Anexo 10. - “Orientações Pós Laqueadura Tubária”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1);), e caso haja necessidade o Médico ou Enfermeiro da UBSF pode reencaminhar a usuária ao Hospital Executante para retorno pós-operatório.

#### 4.1.2. Usuária Gestante

O processo para Gestante, segue o mesmo fluxo de usuárias Não Gestantes, em relação ao tempo de decisão, assinatura dos documentos, e encaminhamentos posteriores, porém, não há necessidade de encaminhamento via SISREG da AIH, pois deverá apresentá-los na Maternidade no dia do parto.

#### **Importante:**

- A realização de cesariana visando o procedimento de esterilização cirúrgica não deverá ser feita;
- **O procedimento de esterilização cirúrgica, não é precedente para a realização de cesariana.**

#### 4.2. Na Vasectomia

- a) O profissional confere a documentação, solicita o procedimento no SIG-SaudeTech:
  - Consulta para Planejamento Familiar Vasectomia (código de procedimento - 99000704) (CID-10 - Z30.2 = Esterilização / CIAP - Y13 = Esterilização Masculina); e
  - Encaminha a documentação digitalizada para Central de Regulação através do endereço eletrônico: [vasectomia.joinville@gmail.com](mailto:vasectomia.joinville@gmail.com) identificando no assunto:
    - o nome do usuário; e

- o procedimento solicitado (exemplo: Nome e Sobrenome – Vasectomia, e ainda, neste momento é necessário confirmar os dados cadastrais e telefones de contato informados no referido sistema);
- b)** O Médico regulador prioriza o agendamento da consulta e autoriza o procedimento cirúrgico;
- c)** Hospital executante:
- Preenche Autorização para Procedimento de Alto Custo (APAC);
  - Agenda a cirurgia, avisa o usuário a data da cirurgia;
  - Comunica cuidados pré e pós-operatórios (Anexo 11. - “Cuidados Pós Vasectomia”, disponível no processo SEI N° 23.0.267467-1);
  - Realiza o procedimento;
  - Solicita espermograma e orienta o usuário a realizá-lo após 25 (vinte e cinco) ejaculações;
- d)** Após o procedimento, o usuário realiza a coleta para espermograma, leva o resultado do espermograma para o enfermeiro na UBSF de referência;
- Se laudo constar resultado quantitativo 00 (zero) de espermatozóide, orienta e finaliza o atendimento;
  - Qualquer resultado diferente do quantitativo 00 (zero), encaminhar o usuário para avaliação médica na UBSF de referência.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres**. Brasília – DF: 2016;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Cadernos de Atenção Básica: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. 1ª edição. 1ª reimpressão**. Brasília – DF: 2013;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde do Homem. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: Plano de Ação Nacional 2009–2011**. Brasília – DF: 2009;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Portaria nº 48, de 11 de fevereiro de 1999**. Dispõe sobre o planejamento familiar e dá outras providências. Brasília – DF: 1999;

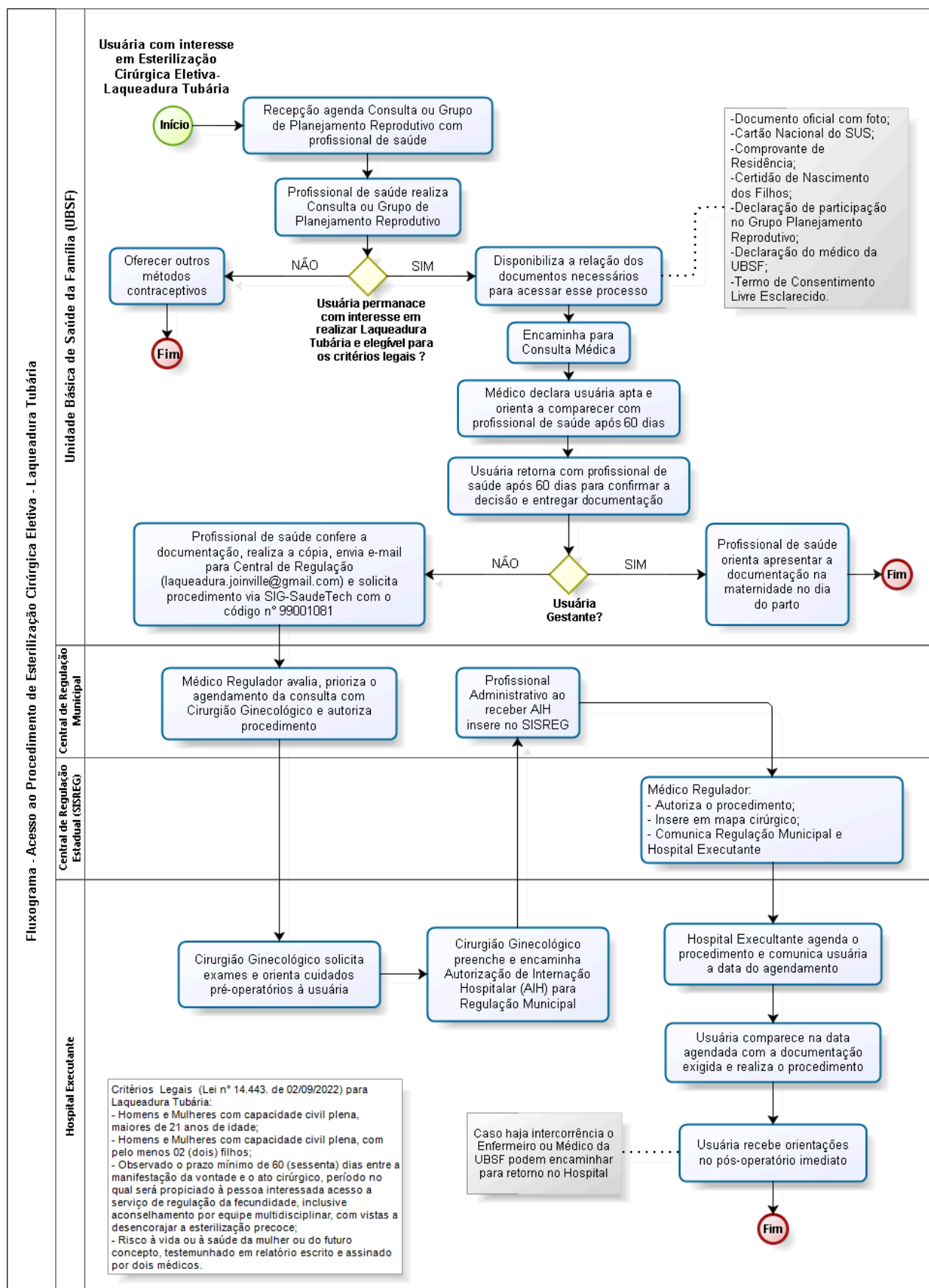
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996**. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. Brasília – DF: 1996;

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018**. Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Brasília – DF: 2018;

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 14.443, de 02 de setembro de 2022**. Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar. Brasília – DF: 2022.



## Anexo 01. Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Laqueadura Tubária



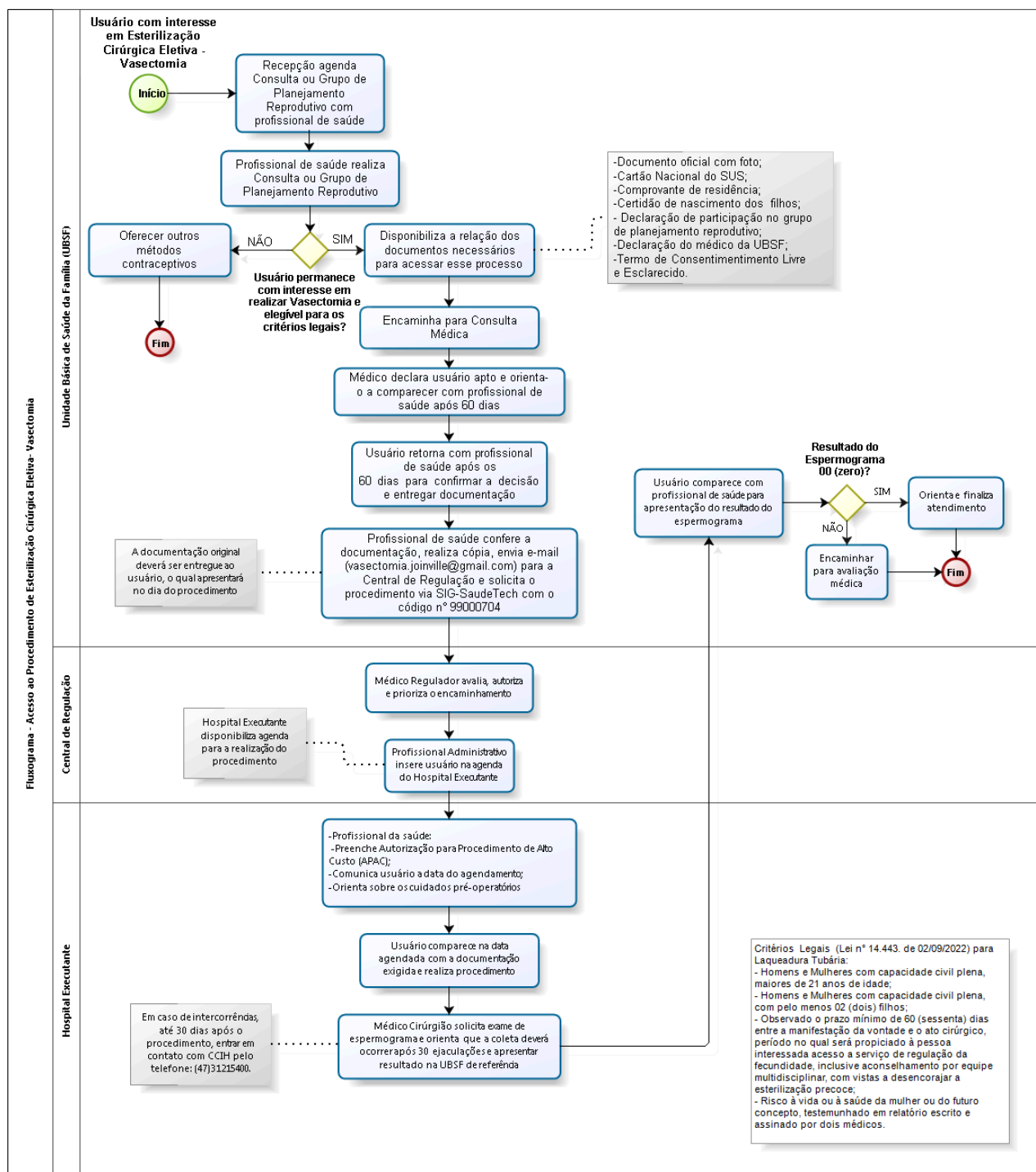
Fonte: NGA, 2024.



Prefeitura de  
Joinville

SAÚDE

## Anexo 02. Fluxograma de Encaminhamento para Esterilização Cirúrgica Eletiva – Vasectomia



Fonte: NGA, 2024.



**Anexo 03. Conferência de Documentação Obrigatória**

## ANEXO 03

## Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva

**Conferência de Documentação Obrigatória**

Documentos apresentados ao Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e anexados ao processo:

- ( ) Declaração de participação da orientação de Planejamento Reprodutivo (grupo ou consulta de enfermagem);
- ( ) Declaração médica da UBSF quanto a aptidão do(a) usuário(a);
- ( ) Comprovante de residência (cópia anexa);
- ( ) Documento oficial com foto e CPF (cópia anexa com foto visível);
- ( ) Certidão de Nascimento dos filhos (cópia anexa);
- ( ) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do requerente (cópia anexa);
- ( ) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.

---

**Assinatura e carimbo do(a) Enfermeiro(a) responsável**

Joinville, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

## Anexo 04. Declaração de Participação em Grupo ou Consulta de Enfermagem sobre Planejamento Reprodutivo

### ANEXO 04

#### Esterilização Cirúrgica Eletiva

Processo para Esterilização Cirúrgica Voluntária e Eletiva destina-se para:

- ( ) Masculina – Vasectomia  
( ) Feminina – Laqueadura Tubária

Unidade Básica de Saúde da Família solicitante:

\_\_\_\_\_

#### Declaração

Declaro que \_\_\_\_\_,  
CPF \_\_\_\_\_, participou de orientação no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
e teve acesso às **informações sobre todos os métodos reversíveis e irreversíveis de contracepção e esterilização** no Programa de Planejamento Reprodutivo, optando pelo procedimento de esterilização cirúrgica que é **considerado irreversível**. Possui ao menos um dos critérios abaixo:

- ( ) Possui comprovadamente \_\_\_\_ anos (mais de 21 anos);  
( ) Possui comprovadamente \_\_\_\_ filhos (mínimo 2 filhos vivos).

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura Enfermeiro(a) - Coren/SC.

**Anexo 05. Declaração Médica para Vasectomia**

## ANEXO 05

## Esterilização Cirúrgica Eletiva – Vasectomia

**Declaração Médica**

Declaro que \_\_\_\_\_,  
CPF \_\_\_\_\_, realizou no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, avaliação  
clínica e não foi detectada: infecção local ou sistêmica, massa escrotal, Infecção  
Sexualmente Transmissível (IST), portanto o parecer sobre a Esterilização Cirúrgica  
Eletiva neste momento é:

( ) Parecer **NÃO FAVORÁVEL** à indicação do usuário à Esterilização Cirúrgica  
Definitiva.

( ) Parecer **FAVORÁVEL** à indicação do usuário à Esterilização Cirúrgica Definitiva  
(deverá realizar avaliação pré-cirúrgica), mediante livre consentimento.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura do(a) Médico(a) - CRM/SC.

Prefeitura de  
Joinville

SAÚDE

Prefeitura de  
Joinville

SAÚDE

**Anexo 06. Declaração Médica para Laqueadura**

## ANEXO 06

## Esterilização Cirúrgica Eletiva – Laqueadura Tubária

**Declaração Médica**

Declaro que a usuária \_\_\_\_\_,  
CPF \_\_\_\_\_ realizou no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, avaliação  
clínica e não foi detectada: Infecção local, sistêmica ou Sexualmente Transmissível  
(IST), bem a como indicação do procedimento por Risco a vida, caso haja uma nova  
gestação, ou condição de vulnerabilidade social, portanto dou o seguinte parecer:

- ( ) Parecer **NÃO FAVORÁVEL** à indicação da usuária à Esterilização Cirúrgica Definitiva.
- ( ) Parecer **FAVORÁVEL** à indicação da usuária à Esterilização Cirúrgica Definitiva  
(deverá realizar avaliação pré-cirúrgica), mediante livre consentimento, .

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do(a) Médico(a) - CRM/SC.

Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE

**Fonte:** NGA, 2024.Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE

## Anexo 07. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Laqueadura Tubária para Gestantes

### ANEXO 07

#### Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária para Gestantes

Eu, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ anos, CPF \_\_\_\_\_, e Cartão Nacional de Saúde nº \_\_\_\_\_, venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizar e manifestar meu desejo de ser submetida ao procedimento de Esterilização Cirúrgica Eletiva de Laqueadura Tubária para Gestante por minha livre e espontânea vontade e **DECLARO** que:

Informo que fui esclarecida, por meio de reuniões, consulta de enfermagem e médica, informações preventivas e educativas sobre os meios e técnicas disponíveis para a regulamentação da fecundidade e seus riscos, bem como do período, **mínimo de 60 dias**, entre a manifestação de minha vontade (por meio deste documento) e o procedimento cirúrgico, conforme a Lei 9263/1996 alterada pela Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 2022 e que, de acordo com a mesma Lei, desde que observado esse prazo mínimo, é permitida a laqueadura durante o período do parto **DECLARO** que:

1. A intervenção de laqueadura tubária consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas ou retirada das mesmas (salpingectomia), com o objetivo de impedir gravidez, e que para realização deste procedimento existem várias formas de cirurgia:
  - **Laparoscópica** – cirurgia realizada por meio de 3 ou 4 pequenos cortes realizados no abdome;
  - **Laparotomia** – cirurgia realizada pelo abdome semelhante a cesárea;
  - **Peri umbilical** – após parto vaginal, entre 24h e no máximo 48h, respeitando a *Golden hour* e a involução uterina pois neste período a altura uterina estará adequada para a realização do procedimento;
  - **Vaginal** – cirurgia realizada pela vagina;
  - **Peri-cesárea** – laqueadura tubária realizada oportunamente durante a cesariana no momento da cesárea previamente indicada por motivo obstétrico;
2. Entendo também que a realização de cesariana com intuito de realização de esterilização feminina continua sendo proibida por lei;
3. Qualquer cirurgia que venha a ser escolhida necessita de anestesia. O tipo de anestesia será avaliado e escolhido pelo Serviço de Anestesia;
4. Fui orientada de que a laqueadura tubária não é um método 100% eficaz. Existe uma porcentagem de falha de 0,41% que independe do paciente ou do método cirúrgico;
5. Como em toda intervenção cirúrgica, existe um risco de mortalidade derivado do ato cirúrgico e da situação vital de cada paciente;
6. A reversão desta cirurgia, ou seja, a recanalização das tubas uterinas, tem limitada taxa de sucesso reprodutivo, não é disponibilizada nos serviços do SUS;
7. Assim como outros procedimentos cirúrgicos complicações que poderão surgir da laqueadura tubária, são: Intra-operatórias (hemorragias, lesões de órgãos), queimaduras por bisturi elétrico; Pós-operatórias leves e mais frequentes (seromas, hemorragias, cistites, anemia e outras); Pós-operatórias graves e menos comuns (evisceração, apneia, trombozes, hematomas, pelviperitonites, hemorragia e perfuração de órgãos);
8. Se no momento do ato cirúrgico surgir algum imprevisto, a equipe médica poderá variar a técnica cirúrgica programada;

9. O procedimento planejado da esterilização cirúrgica durante o período de parto (após passado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da minha vontade e o parto) poderá sofrer mudanças de técnica ou ser postergado, devido a condições médicas, técnicas ou de estrutura assistencial da maternidade;

10. Caso surjam contraindicações que impossibilitem realizar a laqueadura, entendo que a justificativa será registrada em prontuário e a equipe médica me orientará outro método para evitar gravidez;

11. Existem outros métodos de contracepção que não são irreversíveis como os métodos de barreira, anticoncepção hormonal e dispositivos intrauterinos;

12. Tenho ciência, conforme disposto na Lei 9263/1996 alterada pela Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 2022, que a esterilização será objeto de notificação à direção do Sistema Único de Saúde. Entendi as explicações que me foram prestadas, em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas que me ocorreram. Também entendi que, a qualquer momento, antes que o procedimento de laqueadura tubária se realize e sem necessidade de dar nenhuma explicação, poderei revogar o consentimento que agora presto;

13. Declaro ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento, as quais entendi, e aceitei, comprometendo-me a respeitar integralmente as instruções fornecidas pelo profissional de saúde, estando ciente de que a não observância das orientações, poderá acarretar riscos e efeitos colaterais para eu mesmo.

Portanto, declaro estar em pleno domínio de minha capacidade civil e de discernimento, sem efeito de drogas, álcool, ou emocionalmente alterado. Assim, declaro que estou satisfeita com a informação recebida e que compreendo o alcance e os riscos do procedimento de laqueadura tubária/ cirurgia de esterilização feminina.

O presente Termo de Consentimento Livre Informado, tem validade legal indeterminada, desde a sua assinatura, e poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do usuário e/ou responsável legal, em qualquer momento antes da realização do procedimento, sem prejuízo legal ou restrição ao acesso a outro método.

Para que produza os efeitos legais, assino o presente termo em TRÊS vias com igual teor e validade, recebendo uma das cópias.

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Usuária

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do médico(a) ou enfermeiro(a) da UBSF

Joinville, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\*Imprimir e Assinar em três vias, ficando uma via com o usuário, outra via na UBSF e a outra via deverá ser encaminhada juntamente com os outros documentos, ficando arquivada no hospital executante.

## Anexo 08. Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido para Laqueadura Tubária para Não Gestantes

### ANEXO 08

#### Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Feminina – Laqueadura Tubária

Eu, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ anos, CPF \_\_\_\_\_, e Cartão Nacional de Saúde \_\_\_\_\_, venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizar e manifestar meu desejo de ser submetida ao procedimento de Esterilização Cirúrgica Eletiva de Laqueadura Tubária por minha livre e espontânea vontade e **DECLARO** que:

1. Por meio deste documento, manifesto o desejo de ser submetido à laqueadura tubária por minha livre e espontânea vontade. Também sei que entre a manifestação de minha vontade (por meio deste documento) e o procedimento cirúrgico deverão se passar ao menos 60 dias, conforme a Lei 9263/1996 alterada pela Lei nº 14.443, de 2/09/2022;
2. Recebi informações preventivas e educativas sobre os meios e técnicas disponíveis no SUS para regulamentação de fecundidade e seus riscos por meio de reuniões, consultas médicas e de enfermagem;
3. Recebi as informações referentes à outros métodos anticoncepcionais disponíveis no SUS que também são eficazes e reversíveis;
4. Recebi a informação que a laqueadura tubária é um método cirúrgico de interrupção permanente da fertilidade feminina, que consiste na interrupção da continuidade das tubas uterinas ou na retirada das mesmas;
5. Estou ciente de que caso deseje realizar a cirurgia de **reversão**, a taxa de sucesso reprodutivo é limitada e não disponibilizada pelo SUS;
6. Recebi informações referentes às possíveis complicações decorrentes de qualquer ato cirúrgico tais como: reação adversa e alergia às drogas utilizadas no ato cirúrgico, e complicações durante o procedimento cirúrgico, como parada cardiorrespiratória, morte, hemorragias, e pós cirúrgicas como infecções, dor e sangramento;
7. Recebi a informação que, caso surjam contraindicações clínicas que impossibilitem realizar a laqueadura, a justificativa vai estar registrada em prontuário e o profissional de saúde irá me orientar outro método para evitar a gravidez;
8. Recebi informações que a laqueadura tubária, assim como os demais métodos contraceptivos disponíveis, tem chance de falha, que independem da usuária ou método cirúrgico;
9. Estou ciente de que o método em questão, não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis;
10. Estou ciente que, ao menor sinal ou sintoma de gravidez, devo procurar um serviço de saúde para confirmação do diagnóstico e comunicar este Serviço;
11. Estou ciente de que gozo da liberdade para desistir do procedimento cirúrgico de esterilização definitiva a qualquer momento que antecede o ato cirúrgico. Essa decisão não irá intervir no atendimento e poderá optar por qualquer outro método contraceptivo disponibilizado na rede SUS;
12. Mediante aos itens acima declarados por mim, venho informar que estou em pleno domínio da minha capacidade civil e discernimento, também não me encontro neste momento sob efeito de drogas, álcool ou com algum prejuízo na minha saúde mental. Informo que compreendi todas as informações presentes neste termo e respeitarei as instruções fornecidas pelo profissional de saúde. Saliento que caso não siga as orientações e informações poderá acarretar riscos e efeitos colaterais para mim mesmo.

O presente termo possui legalmente validade indeterminada e também poderá ser revogado a qualquer momento, conforme minha vontade ou de um procurador nomeado por mim. Para efeitos legais, assino este termo em três vias com igual teor e recebo uma cópia deste termo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Usuária

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do médico(a) ou enfermeiro(a) da UBSF

Joinville, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\*Imprimir e Assinar em três vias, ficando uma via com o usuário, outra via na UBSF e a outra via deverá ser encaminhada juntamente com os outros documentos, ficando arquivada no hospital executante.

**Anexo 09. Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido para Vasectomia**

## ANEXO 09

**Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Esterilização Cirúrgica Eletiva Masculina – Vasectomia**

Eu, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ anos, CPF \_\_\_\_\_, e Cartão Nacional de Saúde \_\_\_\_\_, venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizar e manifestar meu desejo de ser submetido ao procedimento cirúrgico de VASECTOMIA por minha livre e espontânea vontade e **DECLARO** que:

1. Por meio deste documento, manifesto o desejo de ser submetido à vasectomia por minha livre e espontânea vontade. Também sei que entre a manifestação de minha vontade (por meio deste documento) e o procedimento cirúrgico deverão se passar ao menos 60 dias, conforme a Lei 9263/1996 alterada pela Lei nº 14.443, de 2/09/2022;
2. Recebi informações preventivas e educativas sobre os meios e técnicas disponíveis no SUS para regulamentação de fecundidade e seus riscos por meio de reuniões, consultas médicas e de enfermagem;
3. Recebi as informações referentes a outros métodos anticoncepcionais disponíveis no SUS que são eficazes e reversíveis;
4. Recebi a informação que a vasectomia é um método cirúrgico de interrupção permanente da fertilidade masculina, causada pela secção dos ductos deferentes, interrompendo a passagem dos espermatozoides para o líquido ejaculado;
5. Estou ciente de que caso deseje realizar a cirurgia de **reversão**, a taxa de sucesso reprodutivo é limitada e não disponibilizada pelo SUS;
6. Recebi informações referentes às possíveis complicações decorrentes de qualquer ato cirúrgico tais como: reação adversa e alergia às drogas utilizadas no ato cirúrgico, e complicações durante o procedimento cirúrgico, como parada cardiorrespiratória, morte, hemorragias, e pós cirúrgicas como infecções, dor e sangramento;
7. Recebi informações que a vasectomia, assim como os demais métodos contraceptivos disponíveis, tem chance de falha, que independem do usuário ou método cirúrgico;
8. Estou ciente de que o método em questão não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis;
9. Recebi orientações referentes aos cuidados pré e pós-operatórios e comprometo-me a realizar o exame de espermograma após 25 (vinte e cinco) ejaculações;
10. Estou ciente de que no caso da minha parceria sexual ter a suspeita de gravidez, devo procurar um serviço de saúde para confirmação ou não do diagnóstico e comunicar este Serviço;
11. Estou ciente de que gozo da liberdade para desistir do procedimento cirúrgico de esterilização definitiva a qualquer momento que antecede o ato cirúrgico. Essa decisão não irá intervir no atendimento e poderá optar por qualquer outro método contraceptivo disponibilizado na rede SUS;
12. Mediante aos itens acima declarados por mim, venho informar que estou em pleno domínio da minha capacidade civil e discernimento, também não encontro-me neste momento sob efeito de drogas, álcool ou com algum prejuízo na minha saúde mental. Informo que compreendi todas as informações presentes neste termo e respeitarei as instruções fornecidas pelo profissional de saúde. Saliento que caso não siga as orientações e informações poderá acarretar riscos e efeitos colaterais para mim mesmo.

O presente termo possui legalmente validade indeterminada e também poderá ser revogado a qualquer momento, conforme minha vontade ou de um procurador nomeado por mim. Para efeitos legais, assino este termo em três vias com igual teor e recebo uma cópia deste termo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paciente

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do médico(a) ou enfermeiro(a) da UBSF

Joinville, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\*Imprimir e Assinar em três vias, ficando uma via com o usuário, outra via na UBSF e a outra via deverá ser encaminhada juntamente com os outros documentos, ficando arquivada no hospital executante.

**Anexo 10. Orientações Pós Laqueadura Tubária**

## ANEXO 10

**ORIENTAÇÕES PÓS LAQUEADURA TUBÁRIA**

PACIENTE:

LAQUEADURA TUBÁRIA

1 - DORES NO PÓS-OPERATÓRIO SÃO COMUNS. USE AS MEDICAÇÕES PRESCRITAS E TENHA CUIDADO PARA MANTER O HÁBITO INTESTINAL SAUDÁVEL. INTESTINO PRESO É UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE DOR NO PÓS-OPERATÓRIO. CASO A DOR SEJA EXAGERADA PROCURAR O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

2 - SANGRAMENTOS PELA FERIDA OPERATÓRIA TAMBÉM SÃO COMUNS ATÉ CICATRIZAÇÃO. CASO HAJA SANGRAMENTO EXAGERADO DEVE-SE PROCURAR O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

3 - BEBA MUITO LÍQUIDO, EVITE INGESTÃO DE AÇÚCAR, FARINHA BRANCA E MUITOS DERIVADOS DO LEITE PARA MANTER HÁBITO INTESTINAL E URINÁRIO NORMAL;

4 - FEBRE OU SECREÇÃO PURULENTA PELA FERIDA OPERATÓRIA OU VAGINA NÃO SÃO SINTOMAS NORMAIS. PROCURE O PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL BETHESDA;

5 - VOCÊ ESTÁ AUTORIZADA A FAZER PEQUENOS ESFORÇOS, PODE TOMAR O PRÓPRIO BANHO, SE ALIMENTAR SOZINHA OU MESMO SUBIR PEQUENOS LANCES DE ESCADA E FAZER PEQUENAS CAMINHADAS. ESFORÇOS INTENSOS E RELAÇÕES SEXUAIS SERÃO LIBERADOS EM 30 DIAS OU APÓS SEU RETORNO;

6 - SE CERTIFIQUE DE QUE SUA BIÓPSIA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL E RETIRE JUNTO AO HOSPITAL BETHESDA. ELA É SUA COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO;

7 - CASO HAJA NECESSIDADE O MÉDICO OU ENFERMEIRO DA UNIDADE BÁSICA PODEM ENCAMINHÁ-LA AO BETHESDA PARA RETORNO PÓS-OPERATÓRIO;

8 - OS PONTOS NÃO PRECISAM SER RETIRADOS.

BOA RECUPERAÇÃO.  
OBRIGADA POR SUA CONFIANÇA.

**HOSPITAL BETHESDA - R. Conselheiro Pedreira, 624 - Pirabeiraba, Joinville - SC, CEP 89239-200.**



Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE



Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE

## Anexo 11. Cuidados Pós Vasectomia

### ANEXO 11

#### CUIDADOS PÓS - OPERATÓRIOS VASECTOMIA

1. Receberá atestado para ir para casa repousar durante 3 dias;
2. Não é recomendado após a cirurgia dirigir carro, moto ou bicicleta, nos 3 primeiros dias;
3. É expressamente proibido ter relações sexuais nos 5 primeiros dias;
4. Não fazer atividade física (que exija força) nos 5 primeiros dias;
5. Tomar medicação prescrita conforme orientação médica, para evitar complicações;
6. Até a alta do paciente realizado pelo médico do posto de saúde, o casal terá que usar método contraceptivo que estiver habituado a usar, (camisinha, anticoncepcional, outros), caso não faça uso de nenhuma proteção, usar camisinha;
7. Fazer o exame espermograma após 30 ejaculações (relações sexuais) e/ou 30 dias depois da cirurgia, ligar para as clínicas conforme orientado e levar a requisição no laboratório;
8. Após receber o resultado de espermograma levar ao médico do Posto de Saúde onde iniciou o processo, ele vai verificar o resultado e dar a alta ao paciente;
9. A infecção hospitalar é uma complicação associada a qualquer internação, e sua ocorrência depende de inúmeros fatores como resistência imunológica do paciente, procedimentos cirúrgicos, utilização de cateteres, tempo de permanência no hospital e principalmente fatores relacionados ao ambiente. A CCIH vem orientar que o paciente siga criteriosamente as orientações fornecidas pelo médico cirurgião/enfermeira em relação aos cuidados com o local da cirurgia no pós-operatório. Caso surjam intercorrências, até 30 dias após a cirurgia, como: febre, dificuldade/ardência/dor ao urinar, presença de secreção purulenta nos pontos e/ou edema, vermelhidão, ruptura, solicitamos que entre em contato com a CCIH pelo telefone (47) 3121-5400.

**HOSPITAL BETHESDA - R. Conselheiro Pedreira, 624 - Pirabeiraba, Joinville - SC, CEP 89239-200.**



Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE

**Fonte:** Hospital Bethesda, 2024.



Prefeitura de  
**Joinville**

SAÚDE